طبع فى 21/10/2026 15:30:41

جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * **طلب علاج أول مرة / متردد**

إسم المريض رباعياً : فاطمة محمد مراد محمد

العنوان : 4ش الاخلاص-خرطة عاصم الجديدة-بولاق الدكرور-الجيزة

المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** بولاق الدكرور

رقم البطاقة : 26811262101726 **رقم التليفون :** 01099960234 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 21-10-2026

العمر(تاريخ الميلاد) : 26-11-1968 **المهنة :** بدون عمل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**

التوقيع:(--------------------------) **التوقيع:**(--------------------------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : جراحات أورام منظار علوي علي المعده تشخيصي [13265] **قسم العلاج :** الاورام

التعليق على التشخيص : ----------------------------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------------------------- **التوقيع:** د/محمد كيلاني

الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------------------------- **التوقيع:** ندى حسن

الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------------------------- **التوقيع:** نرمين رمضان

جوستاف روسي

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ------------------------ **ا.د/** ------------------------ **د/** ------------------------ **د/** ------------------------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : --

خطة العلاج : --

المستشفي : -- **قسم :** --

جهة العلاج : -- **نفقات :** --

ملاحظات : --

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

مدير عام
مديرية الشئون الصحية

ختم
شعار الجمهورية

Name: فاطمة محمد مراد محمد
National ID: 26811262101726

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

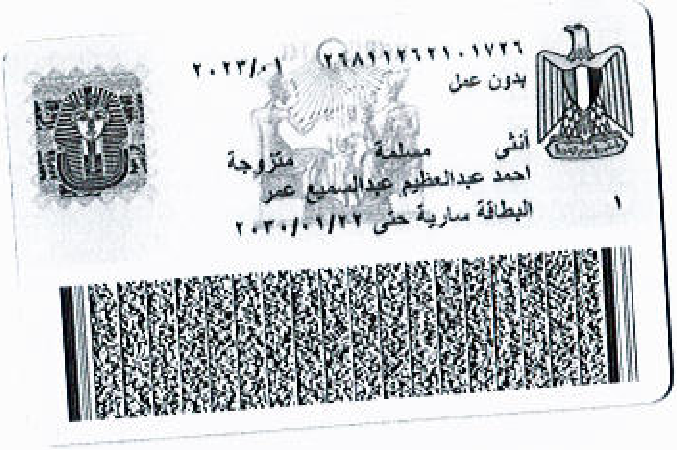
نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : yyyy-mm-dd --:-- --	تاريخ وساعة الخروج : 05-07-2026 01:17 PM

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Diagnostic upper gastrointestinal endoscopy

التاريخ : **05-07-2026**	الوقت : **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



٢٦٨١١٢٦٢١٠١٧٢٦ ٢٠٢٣/٠١

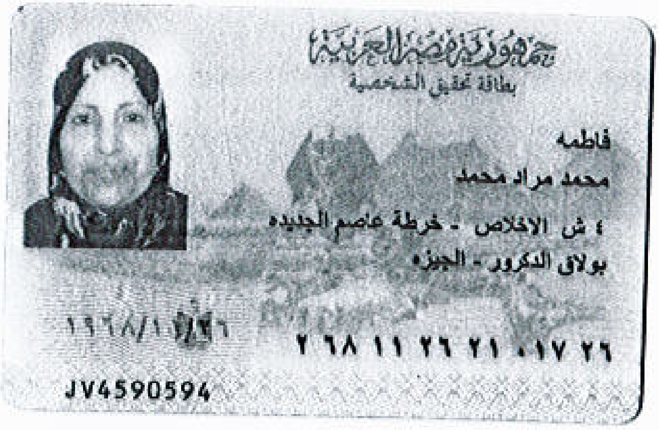
بدون عمل

أنثى مسلمة متزوجة

احمد عبدالعظيم عبدالسميع عمر

١

البطاقة سارية حتى ٢٠٣٠/٠١/٢٢



جمهورية مصر العربية

بطاقة تحقيق الشخصية

فاطمه

محمد مراد محمد

٤ ش الاخلاص - خرطة عاصم الجديده

بولاق الدكرور - الجيزه

١٩٦٨/١١/٢٦

٢ ٦٨ ١١ ٢٦ ٢١ ٠١٧ ٢٦

JV4590594

National ID · Front & Back

[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

MDT FORM 25/6/2024 GM

Name	[illegible] محمد مراد	**MRN**	٨٢٠٠٠٤٢٧
		ID	
Age	53 y	**Phone**	٠١٠٩٩٩٦١٠٣٤٨
Menopausal status	Postmenopausal	**Marital status**	
NRS SCORE		**Family history**	٠١١٤٤٢٧٢٤٤٧٦
BMI		**REASON OF MDT**	Step Adj HR ttt
CO morbidity			

Clinical Data

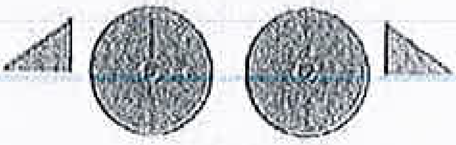
BX:

ER: 6/8	**PR:** 8/8	**HER 2:** —ve	**KI67:** 15%

Sonomammography: 9/2023 Free

Mets Workup:

R [illegible] L



TNM

Recommendations:
12/2018 Ⓛ BCS pT2N2/18, Adj 6 Anthracyclin + PORTH
5/2019 Tamoxifen + Gd ablation
12/2020 Femara
Completed 5 y • 6 Adj Hormonal ttt Consider step HR tt Regular f/u

MDT OUTCOME & PLAN
for 2 more years AI to complete total 7 years adjuvant

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
25/6/2024		D [illegible] 25/6/2024			

Name: فاطمه محمد مراد

MR. : 3203

GUSTAVE ROUSSY

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من

بشأن تقرير طبي للمريض

بقسم:

رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :

تاريخ وساعة الخروج :

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient underwent right breast-conserving surgery (BCS) in December 2018 for a stage II disease with pathologic findings of pT2 N1. Adjuvant chemotherapy with taxanes was recommended, and a port was placed. Tamoxifen was initially prescribed but was switched to letrozole (Femara) in October 2020. The patient has been free of disease since July 2025 and has continued letrozole for three months.

Adjuvant therapy with letrozole (Femara) plus supportive care was continued for three months, with the next follow-up scheduled for 6 September 2026. The plan was subsequently reaffirmed, maintaining letrozole and supportive care for another three-month interval, with the next clinic visit set for 22 November 2026.

تحريرا في ,

التاريخ : 19-09-2026

الوقت :

الطبيب المعالج : نهي سعيد علي محمد

يعتمد ,

Misr International
Hospital Corp.

Prof. Abdalla Khalil
Prof. Ali El Hindawi
Prof. Bahaa Mounir

مستشفى مصر الدولي [illegible]

[illegible]

Name: [illegible] احمد مراد
Report No :-(1371)
Medical report No: 651411
Clinical Data: Breast mass
Specimen: CBS

Age: [illegible]
Word:370

Sex: F
Date:27/12/2018

Referred By Prof [illegible]

PATHOLOGY REPORT

GROSS:

Two specimens were received :

A. A sector of mammary tissue 10x8cm. It showed an ill defined firm gritty grey white mass 2.5x1.5cm (slide1) with least resection margin 2cm (slide2).

B. Axillary tissue specimen 6x5cm. Entangling 15 nodules the largest was 2.8x2.5cm (slides3and4).

MICROSCOPIC:

The mass showed invasive file of malignant ductal cells the cells showed moderate anaplasia. Fair sclerosis was seen. 1 % DCIS component mostly solid type was noticed. The margins were free. Positive deposits were seen in 2/15 of the submitted nodes.

DIAGNOSIS :

Invasive duct carcinoma G2, free margins, positive nodes (2/15) (T2, N1).

Prof. Dr. Abdalla.Khalil.M.D

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى [illegible] السلام
قسم الأشعة

Patient Name: Fatma Mohamed Mourad Mohamed	Date : 24/09/2023
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	
Medical ID: 130/2019	Age : 55 Year(s) Pat. ID: 16264

BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION ULTRASOUND

Indication:

Patient had CBS

Report:

- The breasts are almost entirely fatty (ACR A)
- No left breast suspicious mass lesions, micro calcifications or architectural distortion detected.
- Right breast UOQ focal area of parenchymal distortion owing to prior surgical interference, with post-operative scarring and diffuse edema pattern in the form of increased trabeculations and skin thickness.
- Complementary ultrasound showed rigth breast UOQ focal parenchyma distortion, owing to prior surgical interference with clear operative bed with no evidence of recurrent mass lesions.
- no left breast solid or cystic mass lesions, normal skin thickness and nipple-areola complex.
- Nonspecific left axillary LN, with preserved fatty hila and uniform cortical thickness.
- Free right infra and supra clavicular regions.

Opinion:

- Right breast focal parenchymal distortion owing to prior surgical interference (CBS) with post-operative sequel, with free operative bed with no evidence of recurrent mass lesions (BIRADS 2)
- Normal study of the left breast (BIRADS 1)

Yours truly

Signature Dr. Aya Deabes

24/09/2023 12:40 PM

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

مركز أورام دار السلام

... أورام دار السلام
...
... الباثولوجي

Pathology Report

Name: الطافة محمد مراد

Age: 50 years

Clinical data: Right breast cancer .

Specimen Type: slide revision

Date: 20/1/2019

Lab. Number: SR-12

Gross Description:

Slides received for revision.

Microscopic Examination:

Sections examined from the mass revealed invasive cords, clusters and tubules of moderately anaplastic ductal epithelial cells associated with 10% DCIS and lymphatic tumor emboli. The stroma was fair desmoplastic. No perineural invasion. The resection margins were free. The lymph nodes show positive deposits in 2/15 axillary lymph nodes with extracapsular extension.

Diagnosis:

Breast mass, Slide revision, Wide local excision&axillary lymph nodes, Invasive duct carcinoma, GII. 10% DCIS, positive lymphatic tumor emboli, no perineural invasion.

- Free margins.
- Positive 2/15 axillary lymph nodes with extracapsular excision.
- ER : Positive 8/8.
- PR : Positive 8/8.
- Her2 neu: Negative. Score 1.
- Ki 67: Positive 15% tumor cells.

Prof. Dr. Aml Mareedy

Dr. Marwa Mahmoud

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

NASSER INSTITUTE
ONCOLOGY CENTER

NUCLEAR MEDICINE UNIT

Patient Name: [redacted]
Referring physician: Prof. [redacted]

^{99m}Tc-MDP BONE SCAN

Desired Information : skeletal surveying to detect multiple lesions.

Technique: Anterior and posterior whole body scan performed 2 hours after I.V administration of 20 mCi ^{99m}Tc-MDP:

Report:

- No definite hot spot that account for osseous deposits could be detected allover the surveyed skeleton.
- Degenerative changes are noted in the dorso-lumbar vertebrae.
- Both kidneys are normally seen

Conclusion:

- No definite evidence of metatstatic osseous deposits.

Thanks for reference

Nuclear Medicine Unit

Sherien Mahdy, M.D.

Bone Scan
[[DOCTYPE:BONE_SCAN]]